BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH LẤY MẪU, ĐÓNG GÓI VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN MẪU

Mã hiệu: **XN.QL.13.02** Mã bản: 01-**XN**

Ngày hiệu lực : 13/02/2025

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Nhân viên	Biên soạn	**Hà Thị Hương Trang**	
TK HS TK HHTM TK VS	Kiểm soát chuyên môn	**Nguyễn Thị Hoa** **Nguyễn Hoài Nam** **Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và Ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Mã bản	Nơi lưu giữ	Mã bản	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01 02-04	Khoa Hoá sinh Khoa VS, HHTM

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
Trưởng khoa					
Trưởng phòng QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
3	Nội dung thực hiện	Bổ sung quy định về sự đồng ý của bệnh nhân đối với các quy trình thực hiện trên bệnh nhân
7	Nội dung thực hiện	Bổ sung mục "Thu thập mẫu bệnh phẩm xét nghiệm vi khuẩn nhuộm soi (phương pháp nhuộm gram)"

1. MỤC ĐÍCH

Thống nhất cách lấy, đóng gói vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm tại các khoa gửi mẫu và khoa Hóa Sinh, Huyết Học, Vi Sinh tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Góp phần hạn chế sai sót ở khâu trước xét nghiệm.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho tất cả các khoa gửi mẫu và khoa Hóa Sinh, Huyết Học, Vi Sinh tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Nhân viên các khoa gửi mẫu và khoa Hóa Sinh, Huyết Học, Vi Sinh tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang có trách nhiệm đảm bảo tất cả các mẫu bệnh phẩm được lấy, đóng gói vận chuyển và bảo quản đúng quy trình.
- Lãnh đạo khoa Hóa Sinh, Huyết Học, Vi Sinh có trách nhiệm giải trình, giám sát và phổ biến nhân viên thực hiện đúng quy trình.
- Các khoa phòng liên quan: Phòng Điều Dưỡng, Phòng Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm giám sát thực hiện đúng theo quy trình này.

4. ĐỊNH NGHĨA, CHỮ VIẾT TẮT

- XN: xét nghiệm
- NVQLCL: Nhân viên quản lý chất lượng.

5. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Đối với các xét nghiệm thông thường, khi bệnh nhân đồng ý tự nguyện tuân theo quy trình lấy mẫu đều được coi là sự đồng ý của bệnh nhân đối với các quy trình được tiến hành trên bệnh nhân.
- Đối với các thủ thuật đặc biệt, bao gồm thủ thuật xâm lấn hơn hoặc những thủ thuật có nguy cơ biến chứng cao hơn, bác sĩ lâm sàng cần giải thích chi tiết và cần có sự xác nhận đồng ý thực hiện thủ thuật của bệnh nhân theo biểu mẫu của từng trường hợp, từng khoa/phòng.

5.1 Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao

- Ống chứa mẫu có chứa chất chống đông hoặc không chứa chất chống đông tùy theo yêu cầu cụ thể của từng loại xét nghiệm.
- Lọ nhựa vô trùng nắp đỏ có xoáy vặn
- Que tăm bông vô trùng nắp đỏ
- Bơm tiêm 5ml, 10ml
- Garo, bông, gạc vô khuẩn, cồn 70^0C
- Khay inox, giá đựng mẫu bệnh phẩm, pank, hộp inox đựng bông, gối kê tay.
- Hộp đựng vật sắc nhọn, thùng đựng rác thông thường, thùng đựng rác lây nhiễm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Hộp nhựa, có nắp vận chuyển bệnh phẩm
- Tủ lạnh bảo quản mẫu
- Túi zip đựng mẫu, thùng xốp, đá khô vận chuyển mẫu ngoại viện
- Nếu bệnh nhân cần theo dõi một hay nhiều xét nghiệm trong nhiều ngày, nên lấy máu xét nghiệm vào cùng một giờ với những lần trước.

5.2 Các bước tiến hành

5.2.1 Thu thập bệnh phẩm máu tĩnh mạch làm xét nghiệm đông máu, tế bào huyết học, sinh hóa, miễn dịch, vi sinh miễn dịch test nhanh

5.2.1.1 Chuẩn bị

5.2.1.1.1 Nhân viên y tế:

- Phải là nhân viên y tế (điều dưỡng, kỹ thuật viên,….) đã qua đào tạo, được tập huấn về kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch.
- Phải mang các phương tiện bảo hộ lao động như áo blouse, khẩu trang, găng tay, mũ, kính che mắt…
- Phải sát khuẩn tay bằng cồn trước và sau khi lấy máu cho mỗi bệnh nhân.

5.2.1.1.2 Chuẩn bị bệnh nhân

- Tốt nhất lấy máu bệnh nhân vào buổi sáng sớm, nhịn ăn ít nhất 10-12 tiếng trước khi lấy máu làm xét nghiệm. Trường hợp cấp cứu có thể lấy máu bất cứ lúc nào.
- Cần được tư vấn, giải thích trước khi lấy máu để tránh tâm lý lo lắng sợ hãi, không bị bất ngờ và sẽ hợp tác với nhân viên y tế, hạn chế ảnh hưởng đến kết quả của một số xét nghiệm.
- Không được sử dụng các chất kích thích trước khi lấy máu.
- Tư thế lấy máu: tốt nhất bệnh nhân cần được ngồi nghỉ (hoặc nằm) ổn định 10 phút trước khi lấy máu vì tư thế khác nhau của bệnh nhân khi lấy máu (nằm hay đứng) cũng có thể làm thay đổi nồng độ một số chất trong máu

5.2.1.2 Tiến hành kỹ thuật

- Để bệnh nhân ngồi ghế tựa hoặc nằm ở tư thế thoải mái, đối diện với nhân viên y tế lấy máu. Một tay bệnh nhân để đặt lên gối kê tay sao cho tay không bị gấp, kéo tay áo lên trên khủyu tay (nếu có).
- Xác định đúng bệnh nhân trước khi tiến hành lấy máu bằng cách hỏi tên, tuổi , địa chỉ bệnh nhân, kiểm tra thông tin bệnh nhân đối chiếu với phiếu chỉ định xét nghiệm hoặc phiếu hướng dẫn thực hiện dịch vụ cận lâm sàng, thông tin trên barcode đã dán trên ống. Thông tin phải trùng khớp hoàn toàn giữa bệnh nhân khai, phiếu và barcode mới tiến hành lấy máu.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Xác định vị trí lấy máu: Thường lấy máu tĩnh mạch khuỷu tay, trường hợp đặc biệt có thể lấy máu ở động mạch hoặc mao mạch. ***Trường hợp bệnh nhân đang truyền dịch không lấy máu cùng chi (tay/chân) với vị trí truyền dịch. Tuyệt đối không lấy máu qua dây truyền.***

- Chuẩn bị kim lấy máu. Thử kim lấy máu bằng cách kéo nhẹ pittông từ 2-3 lần. Đưa đầu vát kim hướng lên trên

- Dùng dây garô thắt ở vị trí phía trên cách vị trí lấy máu 2-3 cm. Không thắt quá chặt hay quá lỏng.

- Sát khuẩn vị trí lấy máu bằng bông thấm cồn 70^0 theo vòng xoắn ốc từ trong ra ngoài từ 2-3 lần, để khô tự nhiên.

- Bỏ đầu bảo vệ kim lấy máu.

- Căng da tại vị trí lấy máu.

- Để đầu kim ngay trên vị trí lấy mẫu và xuôi theo đường tĩnh mạch. Đi kim nhanh qua da theo một góc 45^0 vào lòng mạch. Khi thấy máu vào đốc kim thì hạ kim còn một góc 30^0. Cố định đầu kim trong lòng mạch.

- Kéo nhẹ pittông từ từ để lấy mẫu.

- Khi lấy đủ số lượng máu cần cho yêu cầu xét nghiệm thì dừng kéo pittông. Căng da. Rút kim nhanh.

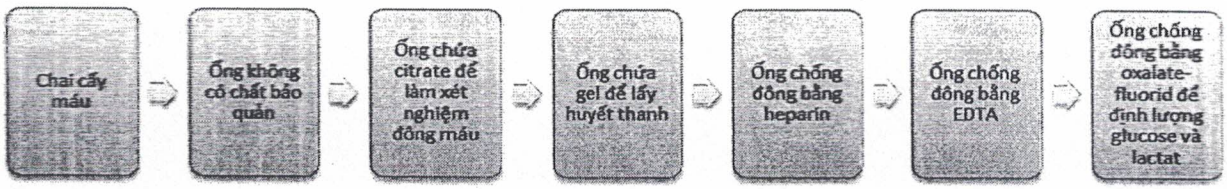
- Tháo dây garô (Thời gian buộc garô không quá 2 phút)

- Băng vị trí lấy máu để cầm máu cho bệnh nhân.

- Lẫy kim vào thùng đựng vật sắt nhọn, bơm máu vào ống nghiệm, nghiêng ống tiêm 45^0 và bơm máu từ từ vào thành ống nghiệm. Tránh tán huyết và tạo bọt (Lưu ý đảm bảo đúng thứ tự phân phối mẫu vào các loại ống nghiệm khác nhau nếu trường hợp chỉ định nhiều xét nghiệm thực hiện trên các mẫu khác nhau. Thứ tự được khuyến cáo như sau:

1. Chai cấy máu
2. Ống không có chất bảo quản
3. Ống chứa citrate để làm xét nghiệm đông máu
4. Ống chứa gel để lấy huyết thanh
5. Ống chống đông bằng heparin
6. Ống chống đông bằng EDTA
7. Ống chống đông bằng oxalate-fluorid để định lượng glucose và lactat

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.



- Đậy chặt nắp ống nghiệm. Lật ngược ống nghiệm nhẹ nhàng 3 - 5 lần để trộn đều các chất chống đông.

- Mẫu bệnh phẩm sau khi lấy xong phải được bảo quản, vận chuyển đến các khoa xét nghiệm

- Yêu cầu thể tích và thời gian gửi mẫu sau lấy:

+ Đối với bệnh phẩm làm đông máu cơ bản:

Thể tích: 2 mL

Thời gian gửi mẫu: Gửi tới phòng xét nghiệm trong vòng 20 phút.

+ Đối với bệnh phẩm làm tế bào máu ngoại vi:

Thể tích: 1.5-2 mL ; riêng với XN Máu lắng: 2 ml

Thời gian gửi mẫu: Gửi tới phòng xét nghiệm trong vòng 2 giờ

+ Đối với bệnh phẩm làm sinh hóa, miễn dịch:

Thể tích: Từ 1.5 – 2 ml máu tĩnh mạch.

Thời gian gửi mẫu: Với phần lớn các xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch gửi mẫu trong vòng 1 giờ sau khi lấy, bảo quản ở nhiệt độ phòng. Với một số các xét nghiệm, thời gian gửi mẫu chỉ trong vòng 15- 30 phút sau lấy máu.

5.2.1.3 Theo dõi và xử lý tai biến

- Nếu bệnh nhân choáng hoặc ngất thì để bệnh nhân nằm nguyên vị trí, lấy nước ấm hoặc nước trà đường ấm cho bệnh nhân uống, để thoáng khí cho đến khi bệnh nhân tỉnh.

- Nếu kim đã lấy máu đâm vào tay nhân viên, rửa dưới vòi nước chảy, không nặn bóp, rửa bằng dung dịch xà phòng, sau đó bằng dung dịch sát khuẩn

5.2.2 Thu thập bệnh phẩm cấy máu

5.2.2.1 Chuẩn bị người bệnh

- Người bệnh được tư vấn giải thích bởi nhân viên y tế.

5.2.2.2 Dụng cụ chứa bệnh phẩm

- Chai cấy máu BacT/Alert.

5.2.2.3 Phương pháp lấy bệnh phẩm:

- Thời điểm: Lấy máu trong thời điểm bệnh nhân rét run hoặc sốt cao >38,5°C, không được chậm vì theo thời gian vi khuẩn trong máu sẽ hạ xuống khi bệnh nhân giảm sốt

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Kỹ thuật
  - Chọn tĩnh mạch, buộc garo.
  - Sát trùng da bằng cách xoay tròn bông sát trùng từ tâm ra ngoài. Sử dụng cồn 70% sau đến iodine 2% (1 phút) hoặc providone iodine (2 phút). Để khô 1-2 phút
  - Lấy 8-10mL máu/1 vị trí x 2 vị trí khác nhau bằng bơm kim tiêm nhựa vô trùng. Nếu là trẻ em lấy 1-3mL máu/1 vị trí x 2 vị trí khác nhau bằng bơm kim tiêm nhựa vô trùng.
  - Tháo dây garo, rút kim ra khỏi tĩnh mạch, cầm máu.
  - Bật nắp chai cấy máu dùng cồn i-ốt 0,025% lau phần nắp cao su trước khi bơm máu
  - Cắm bơm kim tiêm vừa lấy máu qua nắp cao su bơm nhẹ máu để chảy dọc theo chai cấy máu. Sau đó lắc nhẹ không được lắc mạnh tránh vỡ hồng cầu.
  - Sau khi lấy máu xong, sát trùng lại.
- Số lần cấy máu
  - Có thể lấy 2 mẫu máu ở 2 vị trí, cùng thời điểm: 1 bình cấy máu hiếu khí và 1 bình cấy máu kỵ khí. Hoặc 2 bình hiếu khí.
  - Có thể lấy máu nhiều lần trong 1 ngày (ví dụ bệnh Osler).
  - Có thể lấy máu nhiều ngày liên tiếp, nếu các mẫu cấy trong ngày đầu chưa báo dương mà tình trạng BN vẫn nghi ngờ có nhiễm trùng máu.
  - Không nên cấy máu 1 lần.

5.2.2.4 Vận chuyển bệnh phẩm

- Gửi ngay tới phòng xét nghiệm càng sớm càng tốt trong vòng 2 giờ

5.2.2.5 Bảo quản bệnh phẩm

- Tuyệt đối không được bảo quản trong tủ lạnh

5.2.3 Bệnh phẩm nước tiểu

5.2.3.1 Chuẩn bị người bệnh.

- Thời điểm lấy tốt nhất là vào buổi sáng sau khi ngủ dậy
- Bệnh nhân được hướng dẫn vệ sinh bộ phận sinh dục.
- Với bệnh nhân đặt xông tiểu nhân viên y tế cần tư vấn cho bệnh nhân và vệ sinh cổng lấy nước tiểu theo đúng quy trình KSNK.

5.2.3.2 Dụng cụ chứa bệnh phẩm

- Lọ nhựa vô trùng nắp đỏ
- Ống thuỷ tinh nắp xoáy đã được hấp sấy vô trùng.

5.2.3.3 Phương pháp lấy bệnh phẩm nước tiểu giữa dòng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Kỹ thuật: Rửa tay bằng xà phòng, lau khô bằng khăn sạch.

- Đối với bệnh nhân nữ:

- Rửa bộ phận sinh dục bằng xà phòng, thấm khô bằng gạc vô trùng, giữ cho các môi của âm hộ tách biệt.
- Đi tiểu bỏ phần đầu, hứng nước tiểu giữa vào lọ vô trùng, vặn chặt nắp.

- Đối với bệnh nhân nam:

- Kéo phần da qui đầu lên.
- Rửa bộ phận sinh dục bằng xà phòng, thấm khô bằng gạc vô trùng.
- Đi tiểu bỏ phần đầu, hứng nước tiểu giữa vào ống đựng bệnh phẩm, vặn chặt nắp.

- Đối với trẻ em:

- Cho bệnh nhân ngồi trên đùi mẹ, rửa sạch bộ phận sinh dục ngoài, lau khô bằng gạc vô trùng
- Đi tiểu bỏ phần đầu, lấy nước tiểu vào lọ vô trùng, vặn chặt nắp.

- Thể tích: 10-15 mL.

5.2.3.4 Vận chuyển bệnh phẩm

Gửi ngay tới phòng xét nghiệm trong vòng 2h.

5.2.3.5 Tiêu chuẩn từ chối bệnh phẩm

- Lọ đựng bệnh phẩm không đúng, không đảm bảo vô trùng
- Thể tích nước tiểu quá ít
- Nước tiểu để trên 2 giờ

5.2.9 Bệnh phẩm dịch não tuỷ

5.2.9.1 Chuẩn bị người bệnh

- Bệnh nhân cần được tư vấn trước bởi BS lâm sàng (Mục đích của thủ thuật, vị trí thủ thuật, người thực hiện...)

- Cho người bệnh đại tiểu tiện trước khi làm và dặn người bệnh không ăn uống gì ngay trước hoặc sau khi tiến hành phẫu thuật.

5.2.9.2 Dụng cụ chứa bệnh phẩm

- Lọ nhựa vô trùng nắp đỏ
- Ống thuỷ tinh nắp xoáy đã được hấp sấy vô trùng

5.2.9.3 Phương pháp lấy bệnh phẩm

- Thời điểm lấy: do bác sĩ lâm sàng
- Kỹ thuật: Do bác sĩ lâm sàng tiến hành
- Thể tích: 1-2 mL

5.2.9.4 Vận chuyển bệnh phẩm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Gửi ngay đến phòng xét nghiệm càng sớm càng tốt vì các tác nhân gây bệnh ở dịch não tuỷ rất dễ chết

5.2.9.5 Bảo quản bệnh phẩm

- Nếu chưa gửi ngay, có thể bảo quản ở 35-37°C nhưng không quá 2h
- Tuyệt đối không được bảo quản trong tủ lạnh

5.2.9.6 Tiêu chuẩn từ chối bệnh phẩm

- Dụng cụ đựng bệnh phẩm không đúng không đảm bảo vô trùng, không đảm bảo ATSH
- Bệnh phẩm để quá 2h hoặc không được bảo quản đúng
- Thể tích bệnh phẩm quá ít

5.2.5 Bệnh phẩm dịch khác (dịch màng phổi, dịch màng tim, dịch khớp, dịch rửa phế quản, dịch mật, dịch dạ dày,….)

5.2.5.1 Chuẩn bị người bệnh

- Bệnh nhân cần được tư vấn trước bởi BS lâm sàng (mục đích của thủ thuật, vị trí thủ thuật, người thực hiện...)
- Cho người bệnh đại tiểu tiện trước khi làm và dặn người bệnh không ăn uống gì ngay trước hoặc sau khi tiến hành thủ thuật.

5.2.5.2 Dụng cụ chứa bệnh phẩm

- Lọ nhựa vô trùng nắp đỏ
- Ống thuỷ tinh nắp xoáy đã được hấp sấy vô trùng

5.2.5.3 Phương pháp lấy bệnh phẩm

- Thời điểm lấy: do bác sĩ lâm sàng
- Kỹ thuật: Do bác sĩ lâm sàng tiến hành
- Thể tích: 0.5-2 mL
- Riêng dịch phế quản: 0.5-1mL dịch đậm đặc hoặc dịch rửa từ 1-2 mL

5.2.5.4 Vận chuyển bệnh phẩm

- Gửi ngay đến phòng xét nghiệm càng sớm càng tốt

5.2.5.5 Bảo quản bệnh phẩm

- Nếu chưa gửi ngay, có thể bảo quản ở 35-37°C nhưng không quá 2h
- Tuyệt đối không được bảo quản trong tủ lạnh.

5.2.5.6 Tiêu chuẩn từ chối bệnh phẩm

- Dụng cụ đựng bệnh phẩm không đúng không đảm bảo vô trùng, không đảm bảo ATSH
- Bệnh phẩm để quá 2h hoặc không được bảo quản đúng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Thể tích bệnh phẩm đối với bệnh phẩm dịch hút phế quản: dưới 0.5mL hoặc trên 2mL

5.2.6 Thu thập bệnh phẩm mủ nông

5.2.6.1 Chuẩn bị người bệnh

- Người bệnh được tư vấn giải thích bởi nhân viên y tế.

5.2.6.2 Dụng cụ lấy bệnh phẩm

- Que tăm bông vô trùng

5.2.6.3 Phương pháp lấy bệnh phẩm

- Kỹ thuật:
  - Lau sạch mủ trên vết thương bằng gạc vô trùng thấm nước muối
  - Sát khuẩn da bằng cồn iốt 0,025%
  - Để khô
  - Dùng que tăm bông vô trùng quệt lấy mủ ở gờ vị trí tổn thương, chất dập nát hay mô
  - Nếu tổn thương có vẩy, phải làm bong vẩy rồi lấy mủ
- Thể tích: Tăm bông được thấm mẫu bệnh phẩm

5.2.6.4 Vận chuyển bệnh phẩm

- Gửi ngay đến phòng xét nghiệm trong thời gian không quá 2 giờ.

5.2.6.5 Bảo quản bệnh phẩm

- Nếu chưa gửi ngay có thể bảo quản ở nhiệt độ 35-37°C nhưng không quá 2 giờ

5.2.6.6 Tiêu chuẩn từ chối bệnh phẩm

- Tăm bông khô, không thấm mẫu bệnh phẩm.
- Mẫu bệnh phẩm gửi quá 2h.
- Mẫu bệnh phẩm không đảm bảo an toàn sinh học

5.2.7 Thu thập bệnh phẩm mủ sâu

5.2.7.1 Chuẩn bị người bệnh

Người bệnh được tư vấn giải thích bởi nhân viên y tế.

5.2.7.2 Dụng cụ chứa bệnh phẩm

Ống thuỷ tinh nắp vặn đã được hấp sấy vô trùng

Bơm tiêm chứa mủ có nắp đậy hoặc chứa trong dụng cụ vô khuẩn

5.2.7.3 Phương pháp lấy bệnh phẩm

- Kỹ huật
  - Sát khuẩn da bằng cồn iốt 0,025%
  - Để khô
  - Chọc hút mủ bằng bơm tiêm vô khuẩn

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Bơm bệnh phẩm vào ống thuỷ tinh vô trùng.
- Nếu tổ chức viêm chưa hoá mủ thì có thể bơm 0,5-1 ml nước muối sinh lý vô trùng vào tổ chức viêm rồi hút lại. Chú ý đưa mũi kim theo nhiều hướng để hút được mủ ở các vị trí khác nhau.

- Thể tích: 0,5-1 mL

5.2.7.4 Vận chuyển bệnh phẩm

- Gửi ngay đến phòng xét nghiệm càng sớm càng tốt.

5.2.7.5 Bảo quản bệnh phẩm

- Có thể bảo quản ở 35-37°C nhưng không quá 2 giờ
- Tuyệt đối không được bảo quản trong tủ lạnh

5.2.7.6 Tiêu chuẩn từ chối bệnh phẩm

- Mẫu bệnh phẩm gửi quá 2h.
- Mẫu bệnh phẩm không đảm bảo an toàn sinh học

5.2.8 Thu thập bệnh phẩm đường sinh dục

5.2.8.1 Chuẩn bị người bệnh

- Người bệnh được tư vấn giải thích bởi nhân viên y tế.
- Với bệnh nhân Nam tư vấn lấy mủ niệu đạo vào buổi sáng trước khi đi tiểu.
- Với bệnh nhân nữ tư vấn bệnh nhân vệ sinh bộ phận sinh dục.

5.2.8.2 Dụng cụ chứa bệnh phẩm

- Que tăm bông vô trùng

5.2.8.3 Phương pháp lấy bệnh phẩm

Đối với nam giới

- Thời điểm: Lấy mủ ở niệu đạo vào buổi sáng trước khi đi tiểu.
- Kỹ thuật: Lấy mủ ở niệu đạo:
  - Kéo da quy đầu ra sau, vuốt từ gốc dương vật
  - Dùng que cấy vô trùng lấy dịch tiết ở đầu quy đầu
  - Cấy trực tiếp trên đĩa thạch, canh thang.

Đối với nữ giới

- Kỹ thuật:
  - Rửa sạch bộ phận sinh dục ngoài bằng nước, thấm khô.
  - Quan sát vị trí tổn thương: dùng mỏ vịt đưa sâu vào âm đạo, xoay ngang và mở rộng mỏ vịt để nhìn thấy cổ tử cung
  - Bệnh phẩm chủ yếu được lấy từ âm đạo và cổ tử cung, có thể lấy thêm ở 2 tuyến Skene và 2 tuyến Bartholin. Dùng tăm bông vô trùng đưa sâu vào cổ

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

từ cung 2-3 cm, xoay tròn tăm bông và để trong đó 5-10 giây để dịch ngấm vào tăm bông

- Thể tích: Tăm bông phải thấm mẫu bệnh phẩm

Lưu ý:

- Với bệnh nhân nam lấy mẫu tại phòng lấy mẫu đặc biệt tại khoa vi sinh, do nhân viên Khoa trực tiếp lấy.
- Với bệnh nhân nữ mẫu do bác sĩ sản-phụ khoa lấy trong quá trình thăm khám.

5.2.8.4 Vận chuyển bệnh phẩm

- Gửi ngay đến phòng xét nghiệm càng sớm càng tốt

5.2.8.5 Bảo quản bệnh phẩm

- Tuyệt đối không được bảo quản trong tủ lạnh

5.2.8.6 Tiêu chuẩn từ chối mẫu bệnh phẩm

- Tăm bông khô, không thấm mẫu bệnh phẩm
- Bảo quản không đúng hoặc bệnh phẩm để quá 2h.

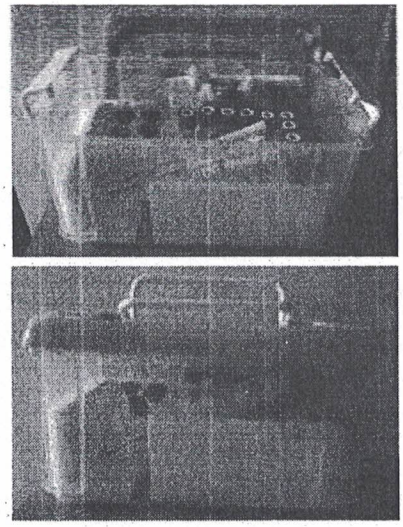
5.2.9 Đóng gói, vận chuyển mẫu

5.2.9.1 Đóng gói mẫu

*** Trong nội bộ bệnh viện:**

- Ống/lọ đựng bệnh phẩm được đậy nắp kín và xếp vào giá phù hợp kích thước theo chiều thẳng đứng.
- Bệnh phẩm từ các khoa trong bệnh viện khi vận chuyển phải được để trong hộp vận chuyển mẫu có nắp và quai xách và có dán nhãn nguy hiểm sinh học. Có thể chèn thêm vật liệu nhằm cố định giá đựng mẫu trong quá trình vận chuyển nhưng không có tác động lên mẫu.

Đóng gói và vận chuyển trong Bệnh viện



ĐÓNG GÓI 2 LỚP

LỚP TRONG	LỚP NGOÀI
Dụng cụ chứa mẫu	Hộp nhựa, gỗ, có nhiều ngăn, có quai xách,

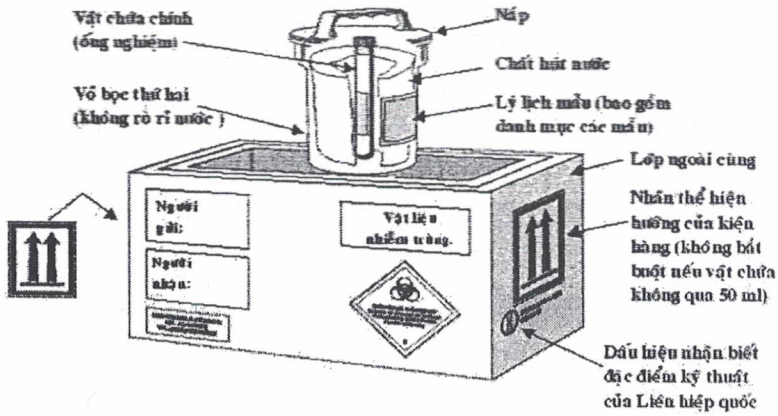
Chú ý:

- Không được để phiếu xét nghiệm tiếp xúc trực tiếp với mẫu, hoặc quấn vào ống đựng mẫu

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

***Gửi mẫu tới các phòng xét nghiệm**

- Bệnh phẩm phải được đóng gói đảm bảo an toàn sinh học, nhất là những loại bệnh phẩm có nguy cơ lây nhiễm cao thì bệnh phẩm phải được đóng gói vận chuyển 3 lớp:



+ Lớp thứ 1: Ống/ lọ chứa mẫu trực tiếp. Ống phải chắc chắn và có nắp kín. Đảm bảo nắp ống đựng mẫu không bị kênh khi chứa mẫu và phải có thông tin nhận dạng trên ống (tên, tuổi, mã điều trị, khoa).
+ Lớp thứ 2: Hộp/ túi chứa các ống đựng mẫu. Hộp/ túi phải chắc chắn, kín tuyệt đối và có khả năng hấp thụ dung dịch nếu ống mẫu bị đổ/vỡ.
+ Lớp thứ 3: Thùng/ hộp chứa các hộp có ống mẫu bệnh phẩm (thùng nên là loại có lớp vỏ xốp và lớp vỏ bìa cứng bên ngoài). Thùng phải chắc chắn, có khả năng cách nhiệt. Khi vận chuyển mẫu phải đảm bảo thùng chứa bệnh phẩm phải được đặt chắc chắn, tránh va đập.

- Bên ngoài thùng có thể đính kèm phiếu yêu cầu xét nghiệm (không để chung phiếu với bệnh phẩm) hoặc có thể để giữa lớp vỏ xốp và lớp vỏ bìa cứng (đặt trên nắp thùng xốp rồi mới đóng lớp bìa cứng).

- Khi gửi bệnh phẩm từ nơi này sang nơi khác trong nước hoặc ra quốc tế, cần bảo quản bệnh phẩm trong phích đá khô. Nói chung, sự thay đổi hoạt độ enzym và nồng độ các chất chuyển hoá không quá ± 10% trong khoảng 2 ngày, nếu nhiệt độ bảo quản mẫu dưới 25 ^{0}C.

- Cần thiết liên hệ trước với phòng xét nghiệm bên ngoài để có các thông tin chi tiết về cách chỉ định, thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

5.2.9.2 Vận chuyển mẫu bệnh phẩm

- Lựa chọn các phương tiện/ hình thức vận chuyển để đảm bảo thời gian vận chuyển ngắn nhất, trong khi vẫn phải đảm bảo điều kiện bảo quản mẫu trong suốt quá trình vận chuyển.

- Nhân viên vận chuyển mẫu xét nghiệm cần đảm bảo chính xác về mặt thời gian, vị trí tiếp nhận mẫu và hạn chế tối đa những rủi ro đối với phòng xét nghiệm và cả cộng đồng.

- Nhân viên vận chuyển mẫu mang hộp đựng bệnh phẩm PXN để bàn giao mẫu.

- Phiếu yêu cầu xét nghiệm được tạo phần mềm quản lý bệnh viện HIS do bác sỹ lâm sàng. Tồn tại dưới dạng điện tử (có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử), chỉ in ra dạng giấy A4,A5 khi có bất thường. Các phiếu chỉ định dạng điện tử được lưu hành dưới dạng file PDF, lưu trữ trên máy chủ ký số.

5.2.10 Bảo quản mẫu

- Bệnh phẩm cần bảo quản ở nhiệt độ phòng 21-26^{0}C và chuyển đến PXN trong thời gian ngắn nhất kể từ khi lấy máu (trong vòng 2h kể từ khi lấy mẫu với XN tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, 30 phút với XN glucose máu).

- Sau khi nhận mẫu và xác nhận mẫu bệnh đạt đúng tiêu chuẩn ở quy trình nhận và từ chối mẫu bệnh phẩm, nhân viên tiến hành đưa mẫu bệnh phẩm vào nơi thích hợp để tiến hành làm xét nghiệm ngay.

- Nếu mẫu bệnh phẩm chưa được làm xét nghiệm ngay, nhân viên khoa phải tiến hành tách chiết và đưa ngay mẫu bệnh phẩm vào bảo quản thích hợp để tiến hành xét nghiệm sau này tùy theo từng loại XN.

5.3 Kiểm tra chất lượng

- Mẫu không bị đông, vi đông, không bị tán huyết

- Mẫu phải đủ thể tích theo yêu cầu làm xét nghiệm hoặc đúng vạch định mức trên ống

- Mẫu cho vào các ống chứa mẫu theo quy định thứ tự hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm.

5.4 An toàn

- Đảm bảo xử lý lấy kim lấy mẫu, vật sắc nhọn an tòan trong khi lấy máu

- Dụng cụ và rác thải được xử lý theo thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải y tế ban hành 31/12/2015.

5.5 Diễn giải và báo cáo kết quả

Không áp dụng.

5.6 *Những điểm cần lưu ý:*

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Một số yếu tố làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm

- Thời gian nhịn ăn trước khi lấy máu: Nên lấy máu sau thời gian nhịn đói qua đêm, ít nhất là 12h trước khi lấy máu.

Ví dụ: nồng độ các chất glucose, cholesterol, triglycerid, các acid amin, sắt và phosphate tăng lên trong máu sau khi ăn

- Thời điểm lấy máu: Do có sự thay đổi nhịp sinh học, nồng độ một số chất có thể thay đổi tùy theo thời gian lấy máu

Ví dụ: nồng độ cortisol có đỉnh cao nhất vào buổi sáng (6-8 giờ) và giảm dần vào buổi chiều và nửa đêm.

- Chất chống đông: Mỗi xét nghiệm thích hợp với mỗi loại chống đông nhất định.

Ví dụ: XN APTT cần chống đông bằng Natri Citrat 3.8%, nếu bị dính Heparin gây hiện tượngAPTT kéo dài giả

- Tư thế của bệnh nhân khi lấy máu: Tư thế khác nhau của bệnh nhân khi lấy máu (nằm hay đứng) cũng có thể làm thay đổi nồng độ một số chất trong máu.

Ví dụ: Sự thay đổi tư thế bệnh nhân từ nằm sang ngồi: Urê giảm 3%, Kali tăng 3%, Canxi tăng 4%, Creatinin tăng 5%,.. đặc biệt Cholesterol tăng 18%.

- Vị trí lấy máu: Lấy máu ở vị trí có ven chuyền dịch sẽ gây sai số tất cả các xét nghiệm do làm pha loãng mẫu máu hoặc tăng cao các xét nghiệm

Ví dụ: Nồng độ glucose máu có thể tăng rất cao nếu máu được lấy ở cùng tay đang được truyền glucose hoặc làm loãng hàm lượng HC, Hb

- Sự tan huyết: Tan huyết gây ra do sai sót trong quá trình lấy máu ảnh hưởng đến nồng độ một số chất

Ví dụ: Tăng các thành phần như kali, phosphate... trong huyết tương và làm tăng hemoglobin dẫn đến gây nhiễu trong một vài phương pháp xét nghiệm.

- Lấy máu không đủ thể tích: Lấy máu không đủ thể tích so với tỷ lệ chống đông ống chứa mẫu làm ảnh hưởng đến KQ.

Ví dụ: XN các Đông máu phải đủ thể tích 2ml, nếu đúng tỷ lệ giữa chống đông và máu toàn phần dẫn đến rối loạn PT, APTT, Fib.

6. LƯU TRỮ HỒ SƠ

6.1. Hồ sơ, biểu mẫu

Không áp dụng

6.2. Phụ lục

Không áp

7. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay dịch vụ khách hàng	STDVKH.XN
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Công căn số 2455/BVĐKĐG-QLCL về việc cập nhật một số nội dung trong Sổ tay khách hàng khối xét nghiệm	

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn lấy mẫu đóng gói, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm, năm 2017, Cục Y tế Dự phòng – Bộ Y tế.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.